



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 13-10-2024 16:24:37

Página 1 de 3

Información Paciente			N° Epicrisis	
Nombre	: Aaron Jesus Gonzalez Araya	Rut	: 20.056.549-5	N° Archivo : 1528574
Edad	: 32a 8m 1d	Fecha Nacto:	12/02/1992	Sexo : Masculino
Dirección	: Panqui 4394 Villa La Frontera	Comuna	: Puente Alto	Teléfono : 9 8276 1232

Información Hospitalización			
Unidad de Ingreso	: Upc - Uci Adulto	Fecha Ingreso	: 10/10/2024 20:55
Unidad de Egreso	: Upc - Uci Adulto	Fecha Egreso	: 13/10/2024 16:10
		Días Estadía: 3	

Motivo o Diagnóstico de Ingreso
Trauma torácico

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico
EPICRISIS

EPICRISIS

Nombre: Aaron Gonzalez Araya
Edad: 32 años
RUT: 20.056.549-5
FI CASR: 10.10.2024
FI UCI: 12.10.2024

ANTECEDENTES

Intento de autolisis en agosto 2024 + Fractura de diáfisis ulnar op agosto 2024 (red + OTS)
Apendicectomía julio 2023
Depresión
Farmacos: Diazepam, Naproxeno, Quetiapina ,Pregabalina, Cefadroxilo, Paracetamol
Tabaco: 10 al día OH: Ocasional Otros: Policonsumo (Pasta base, cocaína)

ANAMNESIS PROXIMA

Paciente con antecedentes descritos, datos obtenidos de ficha médica, sin familiares al momento del ingreso. Ingres a CASR traído por SAMU por herida penetrante torácica izquierda, aparentemente tras intento autolítico. Polipnea hasta 40 rpm, Sat 70%, taquicárdico EcoFast + para neumotórax bilateral por lo que instala pleurostomía bilateral. Dada hemodinamia alterada, dada presencia de livideces, y compromiso de conciencia, se decide IOT.
Persiste con compromiso hemodinámico tras administración de 2500ml de cristaloides, con 3 DVA (noradrenalina, epinefrina, vasopresina), por lo que, se decide uso de azul de metileno, logrando disminución progresiva de drogas vasoactivas, cursando con falla orgánica múltiple (renal, hepático, vasoplejia en mejoría, coagulopatía en curso)

Se solicitan marcadores virales ante eventual requerimiento de TRR. Ingres a UCI para estabilización y manejo.

LABORATORIO INGRESO

Hb 11.6 PQT 22000 GB 6930 PCR <1.0 BUN 28 Crea 4.94 ELP 138/2.78/115 pH 7.137 pCO2 28.9 HCO3 9.6 Lact 9.8 Amonio 0.73 BT 2.72 BD 0.98 FA 142 GGT 67 GOT 2007 GPT 1297 LDH 5032 Gluc 106 INR>10 TTPA >180

Fecha Epicrisis : 13/10/2024 16:24

Página 1 de 3

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:37

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 13-10-2024 16:24:37

Página 2 de 3

DIAGNÓSTICOS INGRESO

- Herida penetrante torácica
- ** Neumotorax bilateral con tubo pleural bilateral
- Sospecha de intoxicación
- ** IOT 10/10/24
- Falla orgánica múltiple
- ** Hepático
- ** CID
- ** Renal
- **Coagulopatía
- Heridas cortantes cuello
- Intento de autolisis
- Ant trastorno por uso de sustancias (cocaína+PBC), ant. Esquizofrenia?

EVOLUCIÓN UPC

Paciente evoluciona en malas condiciones generales, hemodinámicamente inestable con hipotensión profunda, requerimientos al alza de drogas vasoactivas (noradrenalina 0.5, adrenalina 0.55 y vasopresina 0.05) y sangrado generalizado (por coagulopatía), se realiza reanimación con cristaloides, hemoderivados (transfusión masiva) y se realiza pulso de hemofiltración de alto volumen sin respuesta, paciente fallece el 13/10/2024 a las 12:05 PM.

Se notifica a carabineros iniciando denuncia, a la espera de N° folio y fiscal, se traslada cuerpo a Anatomía Patológica (corroborado con unidad y coordinación de turno UPC).

DIAGNÓSTICOS ALTA

1. Síndrome disfunción multiorgánica
 - Disfunción circulatoria refractaria
 - Insuficiencia respiratoria aguda multifactorial, grave
 - Injuría renal aguda AKI KDIGO III
 - a. Terapia reemplazo renal 12/10
 - b. Acidosis metabólica severa
 - Falla hepática aguda fulminante
 - a. Hipoglicemia severa persistente
 - Coagulopatía
2. Shock mixto refractario
 - Shock hemorrágico 2° trauma penetrante torácico
 - a. Hemoneumotórax bilateral -> Pleurostomía bilateral
 - b. Sangrado activo M. pectoral izquierdo
 - c. Coagulopatía severa (trauma-shock) -> Sangrado masivo generalizado
 - Shock vasopléjico, origen desconocido
 - a. Pulso HFAV 12/10
 - Obs Intoxicación por drogas
 - VMI 10-13/10
3. Intento autolisis
 - Herida torácica por arma blanca
 - Heridas cortantes cervicales
4. Antecedentes

Diagnóstico de Egreso

Trauma torácico (Neumotórax, hemotórax, fracturas costales, contusión pulmonar) -

Condición de Egreso

Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente fallece a las 12:05, se notifica a carabineros y se dispone para traslado a servicio medico legal.

Plan Post Alta

Fecha Epicrisis : 13/10/2024 16:24

Página 2 de 3

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 12:37

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente

Valerie Philp Sandoval

Médico Tratante (Staff)